

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 12 năm 2024

HƯỚNG DẪN

Về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội theo Thông tư 187/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Căn cứ Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ, công nhân và viên chức quốc phòng (sau đây gọi tắt là Nghị định 76/NĐ-CP);

Căn cứ Thông tư số 187/2017/TT-BQP ngày 09/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định một số điều về tiêu chuẩn vật chất quân y của Nghị định số 76/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư 187/TT-BQP);

Căn cứ Hướng dẫn số 3375/HD-HC ngày 21/10/2024 của Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội theo Thông tư 187/2017/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phòng Hậu cần - Kỹ thuật hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ

1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ

a) Đối tượng hỗ trợ: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, có thời gian làm việc trong môi trường quân sự độc hại theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định⁽¹⁾, đã kết hôn, bị hiếm muộn, vô sinh⁽²⁾.

b) Điều kiện được hỗ trợ

- Đã được khám, sàng lọc hiếm muộn, vô sinh và điều trị hỗ trợ sinh sản (bao gồm điều trị hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định của pháp luật) sau ngày 01/7/2016 (thời điểm Nghị định 76/NĐ-CP có hiệu lực) tại các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội được Bộ Y tế công nhận⁽³⁾. Có đủ hồ sơ điều trị, hóa đơn chứng từ hợp lệ để thanh quyết toán; trường hợp không giữ được hóa đơn chứng từ phải có xác nhận của cơ sở điều trị về kinh phí đã chi trả.

- Trường hợp cả hai vợ chồng đang công tác trong Quân đội, chỉ xét hỗ trợ kinh phí cho một người (chồng hoặc vợ).

⁽¹⁾ Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định được Cục Quân y cập nhật và hướng dẫn các đơn vị hằng năm.

⁽²⁾ Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO): Hiếm muộn vô sinh là tình trạng một cặp vợ chồng chung sống, có quan hệ tình dục thường xuyên không sử dụng biện pháp tránh thai nào nhưng sau 01 năm (với người vợ dưới 35 tuổi) và sau 6 tháng (với người vợ trên 35 tuổi) mà vẫn chưa có thai một cách tự nhiên.

⁽³⁾ Danh sách các cơ sở y tế thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận được Cục Quân y cập nhật và hướng dẫn các đơn vị hằng năm.

- Không thực hiện hỗ trợ đối với cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn, vô sinh ở nước ngoài; các cặp vợ chồng thực hiện hỗ trợ sinh sản để sinh con thứ 3 trở lên (*trừ các cặp vợ chồng có con trước đó đã chết hoặc bị mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận*).

2. Định mức hỗ trợ

- Mức hỗ trợ khám và điều trị hiếm muộn, vô sinh cho người làm việc trong môi trường lao động quân sự độc hại được thực hiện theo chi phí thực tế (thực chi) nhưng không vượt quá tiêu chuẩn quy định của Nghị định 76/2016/NĐ-CP là 50.000.000 đồng/người/năm.

- Các trường hợp hiếm muộn, vô sinh được hỗ trợ tối đa không quá 05 lần.

II. THỦ TỤC, QUY TRÌNH XÉT HỖ TRỢ VÀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Thủ tục đề nghị hỗ trợ

Hồ sơ đề nghị người hiếm muộn, vô sinh gồm các nội dung sau:

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ kèm theo danh sách đề nghị hỗ trợ (*Phụ lục I - Mẫu số 01*).

- Giấy xác nhận sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có thời gian làm việc trong môi trường quân sự độc hại được thủ trưởng đơn vị (cấp trung đoàn và tương đương trở lên) xác nhận (*Phụ lục II - Mẫu số 02*).

- Bản kê khai đề nghị hỗ trợ kinh phí điều trị hiếm muộn, vô sinh (*Phụ lục III - Mẫu số 03*).

- Các giấy tờ, hồ sơ liên quan đến khám, điều trị hiếm muộn, vô sinh tại các trung tâm hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận, gồm:

+ Hồ sơ điều trị: Giấy ra viện hoặc bản sao bệnh án ngoại trú, xét nghiệm nội tiết, tinh dịch đồ.

+ Hóa đơn, chứng từ: Bảng kê chi phí khám bệnh, điều trị của cá nhân điều trị hiếm muộn, vô sinh (*Phụ lục IV - Mẫu số 04*); hóa đơn, chứng từ hợp lệ (hoặc xác nhận của cơ sở điều trị trong trường hợp không giữ được chứng từ, hóa đơn), (*Phụ lục V - Mẫu số 05*).

2. Quy trình xét hỗ trợ

- Hướng dẫn người hiếm muộn, vô sinh lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ (Danh mục hồ sơ theo mục II.1. Thủ tục đề nghị hỗ trợ), mỗi trường hợp lập 03 bộ hồ sơ (01 bộ gốc, 02 bộ phô tô có chứng thực của Thủ trưởng đơn vị).

- Quân y đơn vị phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, kiểm tra hồ sơ, đề nghị hỗ trợ lên các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (Tờ trình kèm danh sách và 02 bộ hồ sơ, trong đó có bộ hồ sơ gốc); quân y đơn vị lưu 01 bộ hồ sơ phô tô có chứng thực để làm thủ tục quyết toán kinh phí.

3. Kinh phí bảo đảm, hồ sơ quyết toán

a) Kinh phí hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh được bảo đảm từ nguồn Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng; hạch toán vào Mục 7000, Tiểu mục 7001, Tiết mục 10, Ngành 53 “Thuốc, bông băng”.

b) Hồ sơ quyết toán kinh phí hỗ trợ hiếm muộn, vô sinh tại các đơn vị bao gồm: Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ do Cục Quân y ban hành; bộ hồ sơ phô tô có chứng thực; danh sách cấp phát và ký nhận của đối tượng được hỗ trợ.

c) Kinh phí hướng dẫn, xét duyệt hồ sơ trích từ nguồn kinh phí nghiệp vụ công tác dân số, gia đình và trẻ em của các đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các cơ quan, đơn vị nắm thực trạng người hiếm muộn, vô sinh của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức gặp gỡ, nắm tâm tư nguyện vọng, động viên tinh thần và tạo điều kiện cho người hiếm muộn, vô sinh điều trị, sinh con; đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, tránh các nguyên nhân, yếu tố gây nên hiếm muộn, vô sinh.

- Thường xuyên rà soát, thống kê, nắm chắc số lượng và tình hình điều trị các đối tượng hiếm muộn, vô sinh trong đơn vị, báo cáo về Công ty (**vào tháng 4 hàng năm cùng với báo cáo 6 tháng đầu năm**) để tổng hợp báo cáo lên trên theo quy định.

- Tổng hợp báo cáo về Công ty (qua Phòng HCKT) kết quả hỗ trợ (*Phụ lục VI – Mẫu số 06*) và những kiến nghị đề xuất trong năm về công tác hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh (**thời gian trước ngày 30/10 hằng năm**).

- Bệnh xá chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tư vấn chuyên môn, hướng dẫn người bệnh đi khám, điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài Quân đội được Bộ Y tế công nhận, có uy tín, tỷ lệ thành công cao; tiếp nhận và tổng hợp hồ sơ; tổ chức thẩm định chặt chẽ, đúng quy định, dân chủ, khách quan, công bằng; trình Hội đồng thẩm định xét duyệt danh sách và mức đề nghị hỗ trợ; gửi tờ trình đề nghị hỗ trợ kèm theo danh sách và hồ sơ gốc về Phòng Quân y/ Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu; thanh quyết toán theo quy định.

Nhận được Hướng dẫn, đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo, có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Công ty (qua Phòng Hậu cần - Kỹ thuật) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- BGĐ Công ty (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: HCKT. T18.

TRƯỞNG PHÒNG

Trung tá Nguyễn Hữu Tùng Lâm